

광역 외상 · 응급의료센터 국가완전책임제

- 개수만 많아 오히려 효과 떨어지는 권역외상센터, 광역 단위 통폐합으로 기능 극대화
- 중증환자 전담하는 광역중증외상 및 광역거점응급의료센터 국가완전책임제 실시
- 응급의료종사자에 대한 법적보호 강화를 통한 핵심의료 붕괴 방지
- 환자 분류 및 이송체계 개편, 항공이송체계 강화를 통한 국민 안전 확보

■ 문제점 및 현황

1. 응급의료, 고위험 분야일수록 소송 리스크로 관련 과목 소멸 일로

- 치료 중 악결과에 대한 의료진의 행위를 광범위하게 과실로 간주하는 판결 잇따르며 핵심의료과목 기피현상 심화. 위험도 높을수록 기피 현상이 뚜렷해져 응급의료 분야 지 원자 멸종 위기

2. ‘살릴수록 적자’, 정부 지정 권역외상센터의 지속가능성 딜레마

- 초기 연구 당시 6개소에 집중투자계획이었던 것과 달리 정치적 이유 등으로 인해 현재 17개소로 쪼개져 운영되고 있어 정책 효과 저조
- 2024년 1월 기준 전국 권역외상센터 17개 중 전문의 수 10명 미만인 센터가 9개소에 달하고 있어 사실상 간판 뿐인 센터가 상당수인 상황. 3~4인씩 조를 짜 24시간 대기 근무를 하는 근무형태를 고려하면, 전문의가 한 자리수인 센터의 경우 의료인력의 부족 으로 제 기능 어렵고 의료진의 소진 또한 가속화
- 외상마취 전문의를 비롯하여 소위 바이탈과 전문의 부족과 현 정부의 왜곡된 의료개혁 강행으로 인한 향후 지속적 전공의 지원 감소 등 상황을 고려했을 때, 17개의 권역외 상센터를 모두 정상적으로 운영하는 것은 사실상 불가능에 가까운 상황
- 정부는 최소한의 필요예산만 지원하는 구조로, 인건비 등 고정 지원 예산 외에 운영시 필요한 추가 인력 충원 및 당직비·병상관리·의약품 비용 등을 모두 각 의료기관이 부담하고 있어 ‘살릴수록 적자’라는 딜레마가 발생하고 있음

2. 3단계로 나눠놓아도 사실상 다 똑같은 응급의료기관

- 정부는 전국 412개의 응급의료기관을 권역센터, 지역센터, 지역기관의 총 3단계로 나누어 지원하고 있으나, 환자 요구·중증도 판단의 어려움·분류체계 자체의 미비점 등으로 인해 실제로는 각 단계의 응급의료기관이 업무상 차별점이 없어 비효율 발생.

- 서울대학교병원 응급의학과 전공의 50% 이상이 경찰조사 경험 有
- 응급실 의료진 한 명만 그만둬도 24시간 운영 불가능한 수준으로, 인력부족으로 인해 축소 및 파행 운영 사례 속출

■ 정책추진방안

1. 응급의료종사자 형사책임 면제 확대 및 응급의료기관·종사자 국가 지원 강화

- 미국 EMTALA를 참고한 한국형 응급진료 가이드라인을 마련하고, 이를 준수 기준으로 명확히 설정하여, 의료인이 해당 기준에 부합하는 진료를 수행했을 경우 형사책임을 면제할 수 있도록 제도를 정비
- 응급환자 수용 병원에 대한 직접 지원(전원수가, 가산수가, 배후진료 대기인력 및 대기 병상, 수술실 수가, 당직 수당 등)
- 안전 요원 및 청원 경찰 권한 강화

2. 권역외상·응급의료체계 광역거점형으로 개편, 고용·운영에서 소송까지 국가가 책임지는 ‘국가완전책임제’ 실시

- 현 권역응급의료센터 중 초중증 응급환자를 위한 광역거점센터 별도 지정. 광역거점센터로 지정된 경우 응급이송체계 통하지 않는 환자 및 정당한 사유 없는 타지역 환자 수용 원칙적 금지(광역별로 2개 수준, 총 10~12개). 광역거점 지정유지조건으로 센터별 진료량 하한선을 설정하여 환자 적극 수용 유도
- 기존 17개 권역외상센터를 5~6개 이내의 광역거점센터로 통폐합하여 센터별 정상 운영 가능성 현실화 및 기능 극대화
- 광역거점외상센터 및 광역거점응급의료센터는 고용·운영에서 소송까지 국가가 전면적으로 책임지는 ‘국가완전책임제’로 운영
- 센터 운영 핵심진료과목의 세부 전문의 핫라인 구축. 센터별 계약제를 통한 유연근무 등의 형태로 복수 진료 활성화(법률 개정사항)

3. 신속한 환자 이송을 위한 환자 분류 재정비 및 항공이송체계 강화

- 신설되는 보건부에 환자 분류 및 이송 상황 대응을 위한 의료 전문성 갖춘 이송전담 관리 부서 신설 ; 항공/지상 이송 요청, 우선순위 결정, 환자 상태 평가, 최적 이송 수단 선택 등을 담당하는 중앙집중형 조정센터 구축
- 지역별 환자 발생빈도 고려하여 시도별 닥터헬기 1대 이상 배치 및 도심 긴급 착륙 지역 확보 의무화.

- 의사가 탑승하는 119응급의료헬기(119Hel-EMS) 시범사업 적극 확대(현재 수도권 및 경남지역 운영중)
- 소방헬기 환자 이송 업무 연계 및 지원 강화

■ 기대효과

- 권역중증외상센터 기능 극대화 및 지속가능성 확보
- 응급의료체계 효율적 개편 및 이송체계 강화를 통한 국민 안전 도모
- 응급의료행위에 법적 보호 강화를 통한 핵심의료 붕괴 방지